

Questions Œdèmes

Résidanat 2025

1/ Le lymphœdème secondaire :

A/ Sa topographie est plutôt distale

B/ Son extension est centrifuge

C/ Est le plus souvent bilatéral

D/ Peut survenir tardivement

E/ Est consécutif souvent à une exérèse ganglionnaire suivie de radiothérapie
des adénopathies axillaires ou inguinales

2/ L'œdème inflammatoire :

A/ Est secondaire à une vasodilatation capillaire

B/ Prend le godet à l'examen

C/ Participe à l'œdème de la thrombophlébite

D/ Est observé au cours de la fasciite nécrosante

E/ Est responsable d'une stase veineuse

3/ Un œdème aigu post traumatique doit faire évoquer :

A/ Un Hématome

B/ Une fasciite nécrosante

C/ Une fracture

D/ Une hémarthrose

E/ Une arthrite

4/ Au cours des œdèmes généralisés :

- A/ Le diagnostic est principalement clinique
- B/ Les caractéristiques de l'œdème orientent souvent l'enquête étiologique
- C/ Le retentissement est apprécié par l'importance de la prise du poids
- D/ La polyurie est un élément de pronostic péjoratif
- E/ L'œdème des séreuses est constant

5/ Au cours de l'œdème de Quincke :

- A/ Un érythème prurigineux et un œdème aigu du visage apparaissent après le contact avec un allergène
- B/ La dyspnée aigue est réversible spontanément
- C/ La détresse respiratoire et le collapsus en font toute la gravité
- D/ Une notion familiale peut être notée.
- E/ Il s'accompagne d'une hémodilution, une hypo protidémie et une hypo albuminémie.

6/ L'œdème angioneurotique :

- A/ Peut être autosomique récessif
- B/ Est caractérisé par un œdème inflammatoire et prurigineux de la face, du cou, du tronc ou des membres
- C/ Dure de deux à quatre jours par poussée
- D/ Peut s'associer à des douleurs abdominales pseudo-chirurgicales
- E/ Est consécutif à un déficit acquis ou congénital en C2 et C4

7/ L'œdème de revascularisation :

- A/ Est de plus en plus rare
- B/ Apparaît en postopératoire, lié à l'hyperperméabilité capillaire ischémique
- C/ Peut être du à la chute de la pression artérielle
- D/ Peut être du aux blessures lymphatiques et à la tension des masses musculaires
- E/ Disparaît spontanément en trois mois

8/ Les œdèmes cycliques idiopathiques :

- A/ Peuvent être localisés ou généralisés
- B/ Touchent la femme jeune en période d'activité génitale
- C/ Touchent principalement le visage et les mains
- D/ S'associent à une prise de poids modérée en période œdémateuse
- E/ Ont comme mécanisme prédominant la rétention hydro sodée

9/ Un œdème généralisé d'origine endocrinienne peut être dû à :

- A/ Une insuffisance post hypophysaire
- B/ Une hyperthyroïdie
- C/ Un diabète
- D/ Une insuffisance surrénalienne
- E/ Une hyperparathyroïdie

10/ L'œdème dû à l'insuffisance veineuse chronique :

- A/ Touche principalement les membres inférieurs
- B/ Est toujours bilatéral
- C/ Peut être primitif ou secondaire
- D/ Est dur et fibreux dès son début
- E/ Peut se compliquer de dermite ocre et d'ulcères

11/ Les indications d'hospitalisation d'un œdème sont :

- A/ Une localisation jugée grave
- B/ Un œdème des séreuses
- C/ Un retentissement viscéral ou hémodynamique
- D/ Une urgence infectieuse
- E/ Un angioœdème récurrent

12/ L'angioœdème histaminique :

- A/ La durée de la crise est de quelques jours
- B/ S'associe à la notion d'atopie
- C/ La crise abdominale est fréquente
- D/ Entraîne un œdème blanc, mou, douloureux de la face surtout des lèvres
- E/ S'associe à la notion de prise alimentaire ou médicamenteuse

13/ Dans la thrombose cave supérieure :

- A/ L'œdème est dit en pèlerine.
- B/ Les veines du cou sont dilatées.
- C/ La circulation collatérale est uniquement thoracique.
- D/ Le visage est congestionné.
- E/ Les céphalées sont rares.

14/ Concernant l'insuffisance veineuse chronique,

- A/ Elle peut être secondaire à une thrombose veineuse profonde.
- B/ Elle est la conséquence d'un dysfonctionnement du système veineux profond et superficiel.
- C/ Elle est toujours bilatérale.
- D/ Sa prévalence augmente avec l'âge.
- E/ Elle peut être la cause de troubles trophiques.

15/ L'œdème localisé d'un membre supérieur peut être dû à :

- A/ Une malformation vasculaire
- B/ Une algodystrophie.
- C/ Un kyste de Baker rompu.
- D/ Une arthrite.
- E/ Une insuffisance hépatocellulaire.

16/ Dans la thrombose veineuse profonde d'un membre inférieur:

- A/ L'œdème est inconstant.
- B/ Le diagnostic est à évoquer devant un cordon veineux douloureux.
- C/ La profession avec position debout prolongée est un facteur favorisant.
- D/ Le diagnostic est confirmé par échographie doppler veineux des membres inférieurs.
- E/ Une dyspnée récente en est un signe de gravité.

17/ L'œdème angioneurotique iatrogène peut être dû à :

- A/ Un inhibiteur de l'enzyme de conversion.
- B/ Un inhibiteur de l'angiotensine.
- C/ Un anticancéreux.
- D/ Un inhibiteur calcique type dihydropyridine.
- E/ Un immunosuppresseur.

18/ L'œdème bleu de Charcot :

- A/ Est consécutif à une striction volontaire d'un segment de membre.
- B/ Un syndrome de Münchhausen est souvent en cause.
- C/ Une phlébite profonde y est souvent associée.
- D/ Une origine endocrinienne en est une cause.
- E/ Il peut révéler des troubles psychiatriques sévères.

19/ Les œdèmes vasomoteurs sont dus à :

- A/ Des troubles de la macrocirculation.
- B/ Un syndrome de Raynaud.
- C/ Une érythermalgie.
- D/ Une algodystrophie.
- E/ Une neuropathie diabétique.

20/ Les œdèmes généralisés sont dus à :

- A/ Une insuffisance cardiaque gauche.
- B/ Un syndrome néphrotique.
- C/ Une entéropathie exsudative.
- D/ Une dénutrition.
- E/ Une cause iatrogène.

21/ Les œdèmes généralisés iatrogènes peuvent être dus à :

- A/ Des anti-inflammatoires non stéroïdiens.
- B/ Des corticoïdes.
- C/ Des oestroprogestatifs.
- D/ Des vaso-dilatateurs.
- E/ Des diurétiques.

Cas clinique 1 :

Une femme de 40 ans consulte pour œdème du visage et des membres inférieurs évoluant depuis trois semaines. Elle est G1P1A0 et sans antécédents particuliers. L'examen trouve une patiente apyrétique, pale, ralentie, TA : 11/8, pouls : 55b/mn et un œdème des membres inférieurs de type rénal. Le reste de l'examen était sans particularités. Bandelettes urinaires : Pt ++, H +, le reste est normal.

1/ La patiente présente des signes d'orientation étiologique de son œdème généralisé, lesquels sont justes ?

- A/ Le terrain de femme jeune
- B/ La tension artérielle à 11/8
- C/ Les anomalies des bandelettes urinaires
- D/ Les antécédents gynécologiques
- E/ La durée et l'évolution des œdèmes

2/ Les examens complémentaires de première intention sont :

- A/ Une TSH
- B/ Un ECBU
- C/ Une protéinurie de 24 heures
- D/ Une échographie rénale
- E/ Une électrophorèse des protéines sériques

3/ Les diagnostic(s) probable(s) chez cette patiente sont :

- A/ Une hypothyroïdie
- B/ Un syndrome de malabsorption
- C/ Un syndrome néphrotique pur

- D/ Un syndrome de Sheehan
- E/ Une infection urinaire

Cas clinique 2 :

Un homme de 45 ans aux antécédents d'éthylisme et d'angine 8 jours avant est hospitalisé pour exploration d'un syndrome œdémateux.

L'examen physique trouve une TA à 120/80 mmHg, une fréquence respiratoire à 17 cycles/mn, un silence auscultatoire à la base pulmonaire droite, une ascite et un œdème bilatéral des membres inférieurs blancs mous gardant le godet et indolores.

1-Quel examen commencez-vous par demander pour déterminer l'origine des œdèmes ?

- A/Une ponction d'ascite
- B/Une échographie cardiaque
- C/Une ponction pleurale
- D/Une échographie abdominale
- E/Une bandelette urinaire

Le lendemain de son admission, le patient se plaint d'une dyspnée aigue avec crachats hémoptoïques.

L'examen trouve une température à 38°C, une fréquence cardiaque à 110 batt/mn, une fréquence respiratoire à 22 cycles/mn, un silence auscultatoire à la base droite, une palpation douloureuse de l'hypochondre droit avec reflux hépato jugulaire et une douleur avec tension du mollet gauche.

Le bilan de l'admission trouve:

- *NFS : Hb=13g/dl, leucocytes à 4500/mm³, plaquettes= 520000/mm³, K⁺ = 3,6 mmol/l, protidémie= 40g/l, urée sanguine =5 mmol/l, créatinine sanguine= 65µmol/l, glycémie= 5,2 mmol/l, albuminémie= 14g/l,
- *TP= 70%,
- *CPK= 150UI/l, LDH=1200UI/l,
- *Protéinurie= 5g/24h

2-Choisissez parmi les propositions suivantes le diagnostic le plus probable ?

- A/Une cirrhose éthylique décompensée par une infection d'ascite
- B/Une hypothyroïdie décompensée par une infection pulmonaire
- C/Une insuffisance cardiaque droite décompensée par une infection pulmonaire
- D/Un syndrome néphrotique pur compliqué d'une phlébite et une embolie pulmonaire
- E/Une glomérulonéphrite aiguë post infectieuse

3-Quel examen demandez-vous en urgence pour vous aider au diagnostic ?

- A/Une radiographie de thorax
- B/Une échographie rénale
- C/Un écho-doppler veineux des membres inférieurs
- D/Une échographie cardiaque
- E/Une biopsie rénale